BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN
PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày tháng 10 năm 2026

DỰ THẢO

HỒ SƠ BỔ SUNG TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG DO PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG PHỤ TRÁCH NĂM 2026

Mục tiêu: C6.3 đạt mức 5; A2.1, A4.1, A4.2, C6.1, C6.2, D2.4 đạt mức 4

PHẦN I. TỔNG HỢP PHẦN CÒN THIẾU VÀ PHƯƠNG ÁN BỔ SUNG

Mục tiêu năm 2026: 6 tiêu chí (A2.1, A4.1, A4.2, C6.1, C6.2, D2.4) đạt tối thiểu mức 4; tiêu chí C6.3 đạt mức 5.

Nguyên tắc chung để lên mức 4: (1) có văn bản được ban hành chính thức (không còn ở dạng dự thảo, đang rà soát); (2) có giám sát định kỳ bằng bảng kiểm; (3) có số liệu đo lường theo tháng hoặc quý; (4) có hành động cải tiến sau giám sát. Mức 5 cần thêm: (5) ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi; (6) đánh giá hiệu quả, chỉ số cải thiện liên tục; (7) có đề tài, sáng kiến hoặc mô hình được chia sẻ.

Ghi chú: *Lưu ý: Tên tiêu chí trong bộ hồ sơ này ghi theo các file "Tóm tắt đạt mức 5" của Phòng Điều dưỡng. Tên tiêu chí A2.1, A4.1, A4.2, C6.3 trong các file này khác với Quyết định 6858/QĐ-BYT (Bộ tiêu chí phiên bản 2.0). Cần xác minh bộ tiêu chí bệnh viện đang áp dụng trước khi nộp hồ sơ tự đánh giá.*

Tiêu chí	Mức hiện tại (ước tính)	Mục tiêu	Phần còn thiếu	Tài liệu bổ sung trong hồ sơ này
C6.3 Chăm sóc toàn diện	3	5	Chưa có quy định phân cấp chăm sóc; kế hoạch chăm sóc chưa chuẩn hóa; chưa giám sát chăm sóc toàn diện; chưa có KPI 2025–2026; chưa có sàng lọc dinh dưỡng; chưa có khảo sát hài lòng về chăm sóc	Phần II: QĐ-C6.3, SOP-C6.3-01, SOP-C6.3-02, BM-C6.3-01 đến BM-C6.3-05, bộ 10 KPI, kế hoạch cải tiến PDCA, lộ trình 3 tháng, danh mục minh chứng
C6.1 Hệ thống quản lý điều dưỡng	3	4	SOP chăm sóc toàn diện, ISBAR chưa ban hành; chưa có KPI theo khoa theo tháng; chưa có biên bản họp ĐDT; chưa đánh giá năng lực	Mục III.1: kế hoạch giám sát năm, BM-C6.1-01 bảng kiểm bàn giao ISBAR, BM-C6.1-02 biên bản họp ĐDT, KPI C6.1, kế hoạch đánh giá năng lực
C6.2 Tư vấn, GDSK	3	4	Khảo sát 2026 chỉ 9 phiếu; chưa lượng giá hiểu biết NB; chưa đo tỷ lệ NB được GDSK	Mục III.2: BM-C6.2-01 phiếu lượng giá (teach-back), cỡ mẫu khảo sát, KPI C6.2
A4.2 Đúng QTKT	3	4	32/47 SOP đang rà soát; 38 sự cố chưa phân tích nguyên nhân	Mục III.3: kế hoạch ban hành SOP, quy trình phân tích sự cố (RCA) theo TT 43/2018, BM-

Tiêu chí	Mức hiện tại (ước tính)	Mục tiêu	Phần còn thiếu	Tài liệu bổ sung trong hồ sơ này
				A4.2-01 kế hoạch khắc phục
D2.4 Xác định NB	4	4 (duy trì, hướng 5)	SOP-D2.4, D2.4A chưa ban hành; Thận nhân tạo 86,8%; chưa đo tỷ lệ đeo vòng	Mục III.4: KPI bổ sung, kế hoạch can thiệp Thận nhân tạo
A2.1 Hướng dẫn, đón tiếp	3	4	PĐD phối hợp; hài lòng ngoại trú 80,19% (<85%)	Mục III.5: phân công ĐD hướng dẫn, BM-A2.1-01 bảng kiểm đón tiếp
A4.1 Kịp thời	3	4	Chưa theo dõi thời gian chờ	Mục III.6: BM-A4.1-01 phiếu theo dõi thời gian chờ

PHẦN II. BỘ HỒ SƠ TIÊU CHÍ C6.3 “NGƯỜI BỆNH ĐƯỢC CHĂM SÓC BẢO ĐẢM TOÀN DIỆN” – MỤC TIÊU MỨC 5

1. Dự thảo Quy định chăm sóc người bệnh toàn diện (QĐ-C6.3)

Điều 1. Phạm vi, đối tượng

Áp dụng cho toàn bộ người bệnh điều trị nội trú tại các khoa lâm sàng; điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, hộ lý và nhân viên tham gia chăm sóc người bệnh của Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân.

Điều 2. Nguyên tắc chăm sóc toàn diện

- Lấy người bệnh làm trung tâm; chăm sóc liên tục 24 giờ, cá thể hóa theo bệnh lý, tuổi, nguy cơ và khả năng tự chăm sóc.
- Bao gồm chăm sóc thể chất (vệ sinh cá nhân, dinh dưỡng, vận động, theo dõi dấu hiệu sinh tồn, phòng loét tỳ đè, phòng té ngã), chăm sóc tinh thần (giao tiếp, hỗ trợ tâm lý, giải thích điều trị) và chăm sóc phục hồi (hướng dẫn vận động, tự chăm sóc, giáo dục sức khỏe).
- Người bệnh và người nhà được tham gia vào kế hoạch chăm sóc.
- Người nhà không thay thế điều dưỡng trong thực hiện kỹ thuật chăm sóc.

Điều 3. Phân cấp chăm sóc (theo Điều 4 Thông tư 31/2021/TT-BYT)

Cấp chăm sóc	Đối tượng	Tần suất đánh giá lại tối thiểu	Người chịu trách nhiệm chính
Cấp I	Người bệnh nặng, nguy kịch, hôn mê, suy hô hấp, suy tuần hoàn, phải nằm bất động, yêu cầu theo dõi sát; phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của điều dưỡng	Mỗi ca trực và khi có thay đổi	Điều dưỡng được phân công, có điều dưỡng trưởng/trưởng tua giám sát
Cấp II	Người bệnh có khả năng vận động hạn chế, cần được điều dưỡng hỗ trợ một phần trong các hoạt động chăm sóc hằng ngày	Mỗi ngày và khi có thay đổi	Điều dưỡng được phân công
Cấp III	Người bệnh tự thực hiện được hầu hết các hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của điều dưỡng	Mỗi ngày	Điều dưỡng được phân công

Ghi chú: *Cần xác minh: Nguyên văn tiêu chuẩn từng cấp theo Điều 4 Thông tư 31/2021/TT-BYT trước khi ban hành. File C6.3 nội bộ có nêu thêm "chăm sóc đặc biệt"; Thông tư 31/2021/TT-BYT quy định 3 cấp, nên đề nghị xếp nhóm đặc biệt vào Cấp I.*

Bác sĩ điều trị và điều dưỡng cùng xác định cấp chăm sóc khi người bệnh nhập khoa; ghi trong hồ sơ bệnh án và phiếu chăm sóc; đánh giá lại khi tình trạng người bệnh thay đổi. Bảng tổng hợp cấp chăm sóc được cập nhật tại bảng công khai buồng bệnh/phòng hành chính khoa mỗi ngày.

Điều 4. Đánh giá nguy cơ bắt buộc

Nguy cơ	Công cụ	Thời điểm	Ngưỡng can thiệp
Té ngã	Thang Morse (đã có trong Quy trình phòng ngừa té ngã 2026)	Trong 8 giờ đầu nhập khoa; mỗi ngày với NB nguy cơ; khi chuyển khoa, sau phẫu thuật, khi dùng thuốc an thần	Morse ≥ 45: nguy cơ cao, áp dụng gói phòng ngừa
Loét tỳ đè	Thang Braden	Trong 8 giờ đầu; mỗi ngày với NB Cấp I, Cấp II	Braden ≤ 18: có nguy cơ; ≤ 12: nguy cơ cao
Suy dinh dưỡng	Công cụ sàng lọc theo Thông tư 18/2020/TT-BYT (bệnh viện chọn NRS-2002 hoặc SGA)	Trong 36 giờ đầu nhập viện; lặp lại mỗi tuần	Sàng lọc dương tính: chuyển đánh giá, can thiệp dinh dưỡng
Đau	Thang điểm đau số NRS 0–10 (trẻ em: FLACC/Wong-Baker)	Khi nhập khoa; mỗi lần đo dấu hiệu sinh tồn; sau can thiệp giảm đau	≥ 4 điểm: báo bác sĩ, can thiệp và đánh giá lại

Ghi chú: *Ngưỡng Morse, Braden là ngưỡng thường dùng trong y văn; Hội đồng Điều dưỡng thống nhất ngưỡng áp dụng của bệnh viện. Thời hạn sàng lọc dinh dưỡng: Cần xác minh với nguyên văn Thông tư 18/2020/TT-BYT.*

Điều 5. Kế hoạch chăm sóc

- 100% người bệnh Cấp I, Cấp II có kế hoạch chăm sóc trong 24 giờ đầu nhập khoa; người bệnh Cấp III có kế hoạch chăm sóc theo mẫu rút gọn.
- Kế hoạch chăm sóc theo 5 bước của quy trình điều dưỡng: nhận định, chẩn đoán điều dưỡng, lập kế hoạch (mục tiêu đo được), thực hiện, lượng giá.
- Lượng giá kết quả ít nhất mỗi ngày và cập nhật khi diễn biến thay đổi; không ghi chung chung, sao chép giữa các ngày.
- Ghi đầy đủ tên người thực hiện, ngày giờ trên phiếu chăm sóc theo mẫu hiện hành của bệnh viện.

Điều 6. Phối hợp đa chuyên khoa

Điều dưỡng chủ động đề xuất và phối hợp: bác sĩ điều trị (thay đổi y lệnh, phân cấp chăm sóc), tổ dinh dưỡng (NB sàng lọc dương tính), khoa YHCT-PHCN (NB hạn chế vận động, sau tai biến, sau phẫu thuật chỉnh hình), khoa KSNK (NB có catheter, ống thông, vết thương nhiễm khuẩn, cách ly), dược lâm sàng (NB dùng thuốc nguy cơ cao). Kết quả phối hợp ghi vào phiếu chăm sóc (SOP-C6.3-02).

Điều 7. Giám sát, đánh giá

- Điều dưỡng trưởng khoa: giám sát hằng tuần, tối thiểu 5 hồ sơ/tuần bằng BM-C6.3-03.
- Phòng Điều dưỡng: giám sát mỗi tháng, mỗi khoa tối thiểu 5 người bệnh; tổng hợp KPI hằng tháng trên phần mềm NT Nursing; báo cáo tại họp điều dưỡng trưởng và Hội đồng Điều dưỡng.
- Khảo sát hài lòng người bệnh về chăm sóc điều dưỡng hằng quý (BM-C6.3-04).

Điều 8. Điều khoản thi hành

Quy định có hiệu lực kể từ ngày ký. Rà soát tối thiểu 02 năm/lần hoặc khi có văn bản mới của Bộ Y tế.

2. SOP-C6.3-01: Nhận định, phân cấp chăm sóc và lập kế hoạch chăm sóc

Bước	Nội dung thực hiện	Người thực hiện	Hồ sơ
1	Tiếp nhận NB, xác định NB bằng 02 thông tin nhận dạng (theo SOP-D2.4), đo dấu hiệu sinh tồn, kiểm tra vòng nhận dạng	Điều dưỡng tiếp nhận	Phiếu chăm sóc
2	Nhận định toàn diện: tình trạng bệnh, ý thức, hô hấp, tuần hoàn, dinh dưỡng, bài tiết, vận động, da, giấc ngủ, tâm lý, tiền sử dị ứng, nhu cầu GDSK	Điều dưỡng được phân công	BM-C6.3-01
3	Đánh giá nguy cơ: Morse, Braden, sàng lọc dinh dưỡng, điểm đau	Điều dưỡng được phân công	BM-C6.3-01
4	Cùng bác sĩ xác định cấp chăm sóc I, II, III; ghi vào hồ sơ bệnh án, bảng công khai khoa	Bác sĩ điều trị, điều dưỡng	Hồ sơ bệnh án, BM-C6.3-01
5	Xác định chẩn đoán điều dưỡng ưu tiên, mục tiêu đo được, can thiệp, thời hạn lượng giá	Điều dưỡng được phân công	BM-C6.3-02
6	Thực hiện chăm sóc và gói phòng ngừa theo nguy cơ (té ngã, loét, dinh dưỡng, đau)	Điều dưỡng, hộ lý	Phiếu chăm sóc
7	Lượng giá mỗi ngày, điều chỉnh kế hoạch và cấp chăm sóc khi diễn biến thay đổi	Điều dưỡng được phân công	BM-C6.3-02
8	Bàn giao theo ISBAR mỗi ca; điều dưỡng trưởng kiểm tra NB Cấp I mỗi ngày	Điều dưỡng, ĐDT khoa	Sổ bàn giao
9	Khi ra viện: GDSK ra viện, hẹn tái khám, dấu hiệu nguy hiểm; tổng kết chăm sóc	Điều dưỡng được phân công	Phiếu chăm sóc

Kỹ thuật chăm sóc thực hiện theo danh mục kỹ thuật chuyên môn điều dưỡng tại Phụ lục XII Thông tư 32/2023/TT-BYT, được sửa đổi bởi Thông tư 25/2026/TT-BYT; kỹ thuật đánh dấu "*" phải có phân công bằng văn bản của người phụ trách chuyên môn.

3. SOP-C6.3-02: Phối hợp đa chuyên khoa trong chăm sóc

Tình huống	Đơn vị phối hợp	Thời hạn	Cách ghi nhận
Sàng lọc dinh dưỡng dương tính, nuôi ăn qua ống thông	Tổ dinh dưỡng – tiết chế	Trong 24 giờ	Phiếu đánh giá dinh dưỡng, phiếu chăm sóc
NB hạn chế vận động, sau tai biến, sau mổ chỉnh hình, nguy cơ loét cao	Khoa YHCT – PHCN	Trong 48 giờ	Phiếu chỉ định PHCN, phiếu chăm sóc
NB có catheter, ống thông, vết thương nhiễm khuẩn, cần cách ly	Khoa KSNK	Trong ca phát hiện	Phiếu giám sát KSNK
NB dùng thuốc nguy cơ cao, có	Khoa Dược (dược	Ngay khi phát	Phiếu báo cáo ADR, phiếu

Tình huống	Đơn vị phối hợp	Thời hạn	Cách ghi nhận
phản ứng có hại của thuốc	lâm sàng)	hiện	chăm sóc
NB lo âu, trầm cảm, có nguy cơ tự gây hại	Bác sĩ điều trị, chuyên khoa liên quan	Ngay	Hồ sơ bệnh án, báo cáo sự cố nếu có

NB Cấp I nằm điều trị trên 7 ngày hoặc có ≥ 2 nguy cơ cao: điều dưỡng trưởng khoa tổ chức trao đổi chăm sóc liên chuyên khoa (có thể lồng vào giao ban khoa), ghi biên bản ngắn.

4. Biểu mẫu

BM-C6.3-01. Phiếu nhận định ban đầu và phân cấp chăm sóc

Ghi chú: *Không ghi họ tên người bệnh trên phần mềm; trên giấy dùng nhãn định danh theo quy định bệnh viện.*

Mục	Nội dung ghi nhận
Thông tin	Mã người bệnh/mã HSBA; khoa; giường; ngày giờ nhập khoa; chẩn đoán
Dấu hiệu sinh tồn	Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở, SpO2, cân nặng, chiều cao, BMI
Nhận định 11 lĩnh vực	Ý thức; hô hấp; tuần hoàn; dinh dưỡng; bài tiết; vận động; da, niêm mạc; giấc ngủ; đau; tâm lý; tiền sử dị ứng
Nguy cơ	Morse: __ điểm □ thấp □ cao | Braden: __ điểm | Sàng lọc dinh dưỡng: □ âm tính □ dương tính | Đau: __/10
Thiết bị xâm lấn	□ Catheter TM ngoại vi □ CVC □ Ống thông tiểu □ Ống thông dạ dày □ NKQ/MKQ □ Dẫn lưu
Cấp chăm sóc	□ Cấp I □ Cấp II □ Cấp III | Bác sĩ ký: ____ | Điều dưỡng ký: ____
Nhu cầu GDSK	□ Nội quy □ Phòng té ngã □ Dùng thuốc □ Dinh dưỡng □ Vận động □ Khác: ____
Phối hợp	□ Dinh dưỡng □ PHCN □ KSNK □ Dược lâm sàng □ Khác

BM-C6.3-02. Kế hoạch chăm sóc cá thể hóa

Ngày giờ	Chẩn đoán điều dưỡng (vấn đề ưu tiên)	Mục tiêu (đo được, có thời hạn)	Can thiệp điều dưỡng	Lượng giá (đạt/chưa đạt, điều chỉnh)	Ký tên
	Ví dụ: Nguy cơ té ngã do yếu chi, Morse 55	Không té ngã trong thời gian nằm viện	Giường thấp, chắn song, chuông gọi trong tầm tay, đi kèm khi vệ sinh, GDSK người nhà		
	Ví dụ: Đau vết mổ 6/10	Đau ≤ 3/10 sau 1 giờ	Thực hiện thuốc giảm đau theo y lệnh, tư thế giảm đau, đánh giá lại sau 1 giờ		

BM-C6.3-03. Bảng kiểm giám sát chăm sóc toàn diện

Cách chấm: mỗi tiêu chí Đạt = 1, Không đạt = 0, Không áp dụng = KAD (loại khỏi mẫu số). Tỷ lệ tuân thủ = tổng điểm đạt / tổng tiêu chí áp dụng × 100%. Hồ sơ đạt khi ≥ 90% và không vi phạm tiêu chí có dấu (*).

STT	Tiêu chí giám sát	Đạt	Không đạt	KAD
1	(*) NB được nhận định ban đầu đầy đủ trong 8 giờ đầu nhập khoa			
2	(*) Có phân cấp chăm sóc, có chữ ký bác sĩ và điều dưỡng			
3	Cấp chăm sóc được đánh giá lại đúng tần suất, phù hợp tình trạng hiện tại			
4	(*) Có đánh giá Morse, Braden, sàng lọc dinh dưỡng đúng thời điểm			
5	NB nguy cơ cao được áp dụng gói phòng ngừa (kiểm tra thực tế tại giường)			
6	Có kế hoạch chăm sóc cá thể hóa, mục tiêu đo được			
7	Kế hoạch được lượng giá mỗi ngày, không sao chép			
8	Theo dõi dấu hiệu sinh tồn đúng y lệnh và cấp chăm sóc			
9	NB được vệ sinh cá nhân, răng miệng; giường, quần áo sạch			
10	NB được hỗ trợ ăn uống, theo dõi khẩu phần theo chỉ định			
11	NB được đánh giá và kiểm soát đau			
12	Catheter, ống thông được chăm sóc, ghi ngày đặt, không có dấu hiệu viêm			
13	NB, người nhà được GDSK phù hợp bệnh lý và được lượng giá hiểu biết			
14	Có phối hợp đa chuyên khoa khi có chỉ định và ghi nhận kết quả			
15	Bàn giao ca theo ISBAR có ghi nhận NB nguy cơ cao			
16	NB được hỏi về hài lòng, được giải thích về điều trị, chăm sóc			

BM-C6.3-04. Phiếu khảo sát hài lòng người bệnh về chăm sóc điều dưỡng

Thang điểm 1–5 (1: rất không hài lòng; 5: rất hài lòng). Hài lòng khi chọn 4 hoặc 5. Cỡ mẫu tối thiểu 30 phiếu/khoa/quý (khoa ít người bệnh: khảo sát toàn bộ NB ra viện trong quý).

STT	Nội dung	1	2	3	4	5
1	Điều dưỡng giới thiệu tên, chào hỏi, thái độ ân cần					
2	Được giải thích trước khi làm thủ thuật, chăm sóc					
3	Được hỗ trợ vệ sinh cá nhân, ăn uống, đi lại khi cần					

STT	Nội dung	1	2	3	4	5
4	Điều dưỡng đến ngay khi gọi					
5	Đau được hỏi và xử trí kịp thời					
6	Được hướng dẫn phòng té ngã, nội quy khoa					
7	Được hướng dẫn dùng thuốc, chế độ ăn, vận động					
8	Được tôn trọng riêng tư khi thăm khám, chăm sóc					
9	Được hướng dẫn khi ra viện, tái khám, dấu hiệu nguy hiểm					
10	Mức độ hài lòng chung về chăm sóc điều dưỡng					

BM-C6.3-05. Bảng tổng hợp KPI chăm sóc toàn diện hằng tháng (theo khoa)

Dùng mẫu số liệu ở mục 5 dưới đây; nhập kết quả vào tab "Tiêu chí chất lượng PĐD" của phần mềm NT Nursing trước ngày 05 tháng sau.

5. Bộ chỉ số đo lường C6.3

Mã	Chỉ số	Công thức	Mục tiêu 2026	Tần suất	Nguồn
KPI-C6.3-01	Tỷ lệ NB nội trú được phân cấp chăm sóc	Số NB có phân cấp / số NB giám sát × 100%	≥ 95%	Tháng	BM-C6.3-03
KPI-C6.3-02	Tỷ lệ NB Cấp I, II có kế hoạch chăm sóc trong 24 giờ đầu	Số NB đạt / số NB Cấp I, II giám sát × 100%	≥ 95%	Tháng	BM-C6.3-03
KPI-C6.3-03	Tỷ lệ hồ sơ chăm sóc đạt (≥ 90% bảng kiểm)	Số hồ sơ đạt / số hồ sơ giám sát × 100%	≥ 90%	Tháng	BM-C6.3-03
KPI-C6.3-04	Tỷ lệ NB được đánh giá nguy cơ té ngã, loét, dinh dưỡng đúng hạn	Số NB đủ 3 đánh giá / số NB giám sát × 100%	≥ 95%	Tháng	BM-C6.3-03
KPI-C6.3-05	Tỷ lệ té ngã	Số lần té ngã / tổng số ngày nằm viện × 1.000	Giảm so với cùng kỳ	Tháng	Báo cáo sự cố
KPI-C6.3-06	Tỷ lệ loét tỳ đè mới mắc	Số NB loét mới / tổng số ngày nằm viện × 1.000	< 2‰	Tháng	Báo cáo sự cố, sổ đi buồng
KPI-C6.3-07	Tỷ lệ NB sàng lọc dinh dưỡng dương tính được can thiệp	Số NB được can thiệp / số NB dương tính × 100%	≥ 90%	Quý	Tổ dinh dưỡng
KPI-C6.3-08	Tỷ lệ NB đau ≥ 4 được đánh giá lại sau	Số NB được đánh giá lại / số NB đau ≥ 4 ×	≥ 90%	Tháng	BM-C6.3-03

Mã	Chỉ số	Công thức	Mục tiêu 2026	Tần suất	Nguồn
	can thiệp	100%			
KPI-C6.3-09	Tỷ lệ hài lòng NB về chăm sóc điều dưỡng	Số phiếu chọn 4–5 ở câu 10 / tổng phiếu × 100%	≥ 90%	Quý	BM-C6.3-04
KPI-C6.3-10	Tỷ lệ NB có chỉ định phối hợp được phối hợp đa chuyên khoa đúng hạn	Số NB đạt / số NB có chỉ định × 100%	≥ 85%	Quý	BM-C6.3-03 mục 14

Ghi chú: *Mục tiêu 2026 là đề xuất, Hội đồng Điều dưỡng quyết định. Chỉ số té ngã, loét tính trên 1.000 ngày nằm viện để thống nhất với chỉ số đang theo dõi (loét 2024: 0,34‰). Đề án 2026–2030 đang ghi "té ngã < 0,3%, loét < 1%", cần sửa cùng đơn vị.*

6. Kế hoạch cải tiến PDCA (yêu cầu mức 5)

Giai đoạn	Nội dung	Thời gian	Phụ trách
P – Lập kế hoạch	Ban hành QĐ-C6.3, SOP-C6.3-01/02, biểu mẫu; tập huấn ĐDT và điều dưỡng 19 khoa; đo số liệu nền tháng 10/2026	10/2026	Phòng Điều dưỡng
D – Thực hiện	Áp dụng phân cấp chăm sóc, kế hoạch chăm sóc cá thể hóa; giám sát hằng tuần tại khoa, hằng tháng của PĐD	11–12/2026	ĐDT khoa, PĐD
C – Kiểm tra	Tổng hợp 10 KPI theo tháng trên NT Nursing; so sánh với số liệu nền; phân tích nguyên nhân khoa chưa đạt	Hằng tháng	PĐD
A – Hành động	Phản hồi tại họp ĐDT, Hội đồng Điều dưỡng; điều chỉnh quy trình; nhân rộng khoa làm tốt; tuyên dương	Hằng quý	Hội đồng Điều dưỡng

Đề xuất 01 đề án/sáng kiến cải tiến gắn với C6.3 (ví dụ: "Ứng dụng phân cấp chăm sóc và kế hoạch chăm sóc cá thể hóa giảm té ngã, loét tỳ đè tại khoa Nội Tổng quát"), có số liệu trước và sau can thiệp, báo cáo tại sinh hoạt khoa học hoặc hội nghị điều dưỡng.

7. Yêu cầu mức 5 và cách đáp ứng

Yêu cầu mức 5 (theo file C6.3)	Cách đáp ứng	Trạng thái
Có quy định, SOP, phân cấp, quy trình bàn giao, theo dõi NB nguy cơ cao	QĐ-C6.3, SOP-C6.3-01, SOP-C6.1-02 (ISBAR), quy trình phòng ngừa té ngã 2026	Dự thảo, chờ ký
Chăm sóc thể chất, tinh thần, phục hồi	Điều 2 QĐ-C6.3; BM-C6.3-03 tiêu chí 8–13, 16	Dự thảo
Phân cấp chăm sóc rõ, có đánh giá lại	Điều 3 QĐ-C6.3; BM-C6.3-01	Dự thảo

Yêu cầu mức 5 (theo file C6.3)	Cách đáp ứng	Trạng thái
Kế hoạch chăm sóc cá thể hóa, có mục tiêu, lượng giá	BM-C6.3-02; KPI-C6.3-02, 03	Dự thảo
Phối hợp đa chuyên khoa	SOP-C6.3-02; KPI-C6.3-10	Dự thảo
Giám sát, đánh giá, cải tiến liên tục	BM-C6.3-03; 10 KPI; PDCA	Cần số liệu ≥ 3 tháng
Người bệnh hài lòng, tham gia chăm sóc	BM-C6.3-04; KPI-C6.3-09	Cần khảo sát quý IV/2026
Ứng dụng CNTT	Phần mềm NT Nursing: theo dõi KPI, sổ đi buồng, sự cố, bảng theo dõi tiêu chí	Đã có
Chỉ số cải thiện, có đề tài/sáng kiến	Đề án C6.3 mục 6	Cần triển khai

8. Danh mục minh chứng cần lưu (hồ sơ C6.3)

- Quyết định ban hành Quy định chăm sóc toàn diện, SOP-C6.3-01, SOP-C6.3-02 (có số, ngày, chữ ký Giám đốc).
- Danh sách tập huấn, bài giảng, bài kiểm tra sau tập huấn (19 khoa).
- BM-C6.3-03 đã chấm: tối thiểu 5 hồ sơ/khoa/tháng, liên tục từ 10/2026.
- Bảng KPI theo tháng (xuất từ NT Nursing), biểu đồ xu hướng.
- Phiếu khảo sát hài lòng và bảng tổng hợp quý IV/2026.
- Biên bản họp ĐDT, Hội đồng Điều dưỡng có nội dung phản hồi kết quả giám sát và hành động cải tiến.
- Biên bản trao đổi chăm sóc liên chuyên khoa (mẫu NB Cấp I).
- Báo cáo đề án/sáng kiến cải tiến có số liệu trước – sau.

PHẦN III. BỔ SUNG CÁC TIÊU CHÍ LÊN MỨC 4

1. C6.1 Hệ thống quản lý điều dưỡng được thiết lập đầy đủ và hoạt động hiệu quả

Việc cần làm

- Ký ban hành SOP-C6.1-01 (chăm sóc toàn diện) và SOP-C6.1-02 (bàn giao ISBAR) đang ở trạng thái rà soát.
- Họp điều dưỡng trưởng hằng tháng, ghi biên bản theo BM-C6.1-02, nhập vào mục Họp định kỳ của phần mềm.
- Tổ chức họp Hội đồng Điều dưỡng 6 tháng đầu năm 2026 (chưa có biên bản trong hệ thống).
- Mở rộng sổ đi buồng ra 19 khoa, tối thiểu 1 lượt/khoa/tháng.
- Đánh giá năng lực điều dưỡng (thang Benner hoặc bảng kiểm tay nghề) cho 166/185 nhân sự chưa được đánh giá; ưu tiên kết hợp kết quả thi tay nghề 2026.

Kế hoạch giám sát điều dưỡng năm (đề xuất)

Nội dung giám sát	Công cụ	Tần suất	Cỡ mẫu
Hồ sơ chăm sóc	BM-C6.3-03	Tháng	5 hồ sơ/khoa
Bàn giao ca ISBAR	BM-C6.1-01	Tháng	3 lượt bàn giao/khoa
Phòng ngừa té ngã	Bảng kiểm trong Quy trình phòng ngừa té ngã 2026	Tháng	5 NB nguy cơ/khoa
Xác định người bệnh	CKL.XNNB.01	Liên tục	Theo Google Form
Tuân thủ QTKT nhóm A	CKL.SOPA.01	Quý	3 kỹ thuật/khoa
Đi buồng	Sổ đi buồng (7 mục)	Tháng	1 lượt/khoa

BM-C6.1-01. Bảng kiểm bàn giao người bệnh theo ISBAR

STT	Nội dung	Đạt	Không đạt
1	Bàn giao đúng giờ, có mặt đủ hai bên, tại giường với NB Cấp I		
2	I – Xác định NB bằng 02 thông tin nhận dạng		
3	S – Nêu tình trạng hiện tại, dấu hiệu sinh tồn bất thường		
4	B – Nêu tiền sử liên quan, dị ứng, thủ thuật đã làm		
5	A – Nêu nhận định điều dưỡng và các nguy cơ (té ngã, loét, dinh dưỡng, đau)		
6	R – Nêu việc cần theo dõi, y lệnh chờ thực hiện, xét nghiệm chờ kết quả		
7	Bàn giao thuốc, vật tư, thiết bị, thuốc gây nghiện – hướng thần (nếu có)		
8	Hai bên ký sổ bàn giao		

BM-C6.1-02. Biên bản họp điều dưỡng trưởng tháng

Thời gian, địa điểm, chủ trì, thư ký, thành phần (số ĐDT có mặt/19). Nội dung bắt buộc: (1) kết quả KPI tháng trước theo khoa; (2) kết quả giám sát và đi buồng; (3) sự cố điều dưỡng trong tháng và bài học; (4) việc khắc phục, người phụ trách, hạn hoàn thành; (5) kiểm tra việc khắc phục của tháng trước.

KPI C6.1

Chỉ số	Mục tiêu
Tỷ lệ hồ sơ chăm sóc đạt	≥ 95% (theo file C6.1)
Tỷ lệ tuân thủ bàn giao ISBAR	≥ 95%
Tỷ lệ tuân thủ chăm sóc NB nguy cơ té ngã	≥ 95%
Tỷ lệ ĐDT tham dự họp tháng	≥ 90%
Tỷ lệ điều dưỡng được đánh giá năng lực trong năm	100%
Số sự cố liên quan chăm sóc điều dưỡng	Giảm liên tục

2. C6.2 Người bệnh được điều dưỡng hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, GDSK phù hợp

- Ban hành quy định GDSK và quy định ghi nhận GDSK trong hồ sơ chăm sóc (thời điểm nhập viện, trong điều trị, ra viện).
- Tăng cỡ mẫu khảo sát ý kiến NB về GDSK: tối thiểu 30 phiếu/khoa/quý (hiện 2026 chỉ có 9 phiếu hợp lệ).
- Áp dụng phiếu lượng giá hiểu biết NB theo phương pháp teach-back (BM-C6.2-01).
- Bổ sung mã QR dẫn tới tài liệu GDSK theo bệnh lý tại buồng bệnh (điểm cộng mức 5).

BM-C6.2-01. Phiếu lượng giá hiểu biết người bệnh sau GDSK (teach-back)

Nội dung đã hướng dẫn	NB nhắc lại đúng	NB nhắc lại chưa đủ, đã hướng dẫn lại	NB không nhắc lại được
Nội quy khoa, cách gọi hỗ trợ			
Phòng té ngã			
Tên thuốc, cách dùng, tác dụng phụ cần báo			
Chế độ ăn, vận động			
Dấu hiệu nguy hiểm cần quay lại viện, lịch tái khám			

KPI C6.2	Mục tiêu (theo file C6.2)
Tỷ lệ NB được GDSK có ghi nhận trong hồ sơ	≥ 95%
Tỷ lệ NB hiểu hướng dẫn (teach-back đạt)	≥ 90%
Tỷ lệ NB hài lòng về GDSK	≥ 90%

KPI C6.2	Mục tiêu (theo file C6.2)

3. A4.2 Người bệnh được điều trị đúng phương pháp và đúng quy trình kỹ thuật (phần điều dưỡng)

- Lập kế hoạch rà soát và trình ký 32 SOP đang rà soát và 4 SOP dự thảo, ưu tiên nhóm kỹ thuật có dấu "*" theo Phụ lục XII Thông tư 32/2023/TT-BYT, sửa đổi bởi Thông tư 25/2026/TT-BYT. Mục tiêu: 100% SOP có hiệu lực trước 31/12/2026.
- Phân tích nguyên nhân 38 sự cố năm 2026 theo mẫu Phụ lục IV Thông tư 43/2018/TT-BYT (nhóm sự cố, nhóm nguyên nhân, mức độ tổn thương); sự cố mức NC2, NC3 phân tích nguyên nhân gốc (RCA).
- Mỗi sự cố có kế hoạch khắc phục (BM-A4.2-01), có người phụ trách, hạn hoàn thành, kiểm tra hiệu quả.
- Giám sát tuân thủ QTKT nhóm A hằng quý (hiện đạt 93%), mở rộng sang kỹ thuật nguy cơ cao: truyền máu, tiêm thuốc nguy cơ cao, đặt ống thông.

BM-A4.2-01. Kế hoạch khắc phục sau sự cố

Mã sự cố	Nguyên nhân gốc	Hành động khắc phục	Người phụ trách	Hạn	Kết quả kiểm tra hiệu quả

4. D2.4 Bảo đảm xác định chính xác người bệnh khi cung cấp dịch vụ (duy trì mức 4, hướng mức 5)

- Ký ban hành SOP-D2.4 và SOP-D2.4A (đã có trong file D2.4 của Phòng); nạp vào phần mềm.
- Thống nhất mã tiêu chí: biên bản HĐĐD 26/12/2025 gọi vòng tay nhận diện là D2.3, file gọi là D2.4. Cần xác minh.
- Bộ phận Thận nhân tạo (86,8%): tập huấn lại, giám sát 2 tuần/lần trong 3 tháng.
- Bổ sung chỉ số: tỷ lệ NB nội trú đeo vòng nhận dạng ≥ 98%; số sự cố nhầm NB = 0.
- Hướng mức 5: in mã vạch/QR trên vòng tay, đối chiếu khi dùng thuốc, lấy mẫu (phối hợp Phòng CNTT).

5. A2.1 Người bệnh được hướng dẫn và đón tiếp (PĐD phối hợp)

- Đơn vị chủ trì: Khoa Khám bệnh, Phòng QLCL. Phòng Điều dưỡng phụ trách nhân lực điều dưỡng đón tiếp, hướng dẫn.
- Phân công điều dưỡng hướng dẫn tại cửa vào, khu khám bệnh giờ cao điểm; hỗ trợ NB cao tuổi, khuyết tật.
- Giám sát đón tiếp hằng tháng bằng BM-A2.1-01; mục tiêu hài lòng ngoại trú ≥ 85% (2024: 80,19%).

BM-A2.1-01. Bảng kiểm đón tiếp, hướng dẫn người bệnh

STT	Nội dung	Đạt	Không đạt
1	Có nhân viên hướng dẫn tại vị trí quy định, đeo bảng tên		
2	Chào hỏi, chủ động hỏi nhu cầu NB		
3	Hướng dẫn đúng nơi đăng ký, nơi khám, nơi làm cận lâm sàng		
4	Ưu tiên NB cấp cứu, cao tuổi, trẻ em, khuyết tật, phụ nữ có thai		
5	Hỗ trợ xe lăn, cáng khi cần		
6	Giao tiếp đúng mực theo quy tắc ứng xử		

6. A4.1 Người bệnh được khám và điều trị kịp thời (PĐD phối hợp)

- Đơn vị chủ trì: Khoa Khám bệnh, Khoa CC-HSTC-CĐ, Phòng KHTH. Phòng Điều dưỡng phụ trách phân loại ưu tiên, thời gian tiếp nhận nhập khoa.
- Theo dõi thời gian chờ bằng BM-A4.1-01, mỗi tháng 1 tuần lấy mẫu, tối thiểu 30 NB.
- Chỉ số: thời gian từ khi có chỉ định nhập viện đến khi NB được tiếp nhận tại khoa; tỷ lệ NB cấp cứu được xử trí ngay ≥ 95% (theo file A4.1).

BM-A4.1-01. Phiếu theo dõi thời gian chờ

Mã NB	Giờ đăng ký	Giờ được khám	Giờ có chỉ định CLS	Giờ có kết quả CLS	Giờ có chỉ định nhập viện	Giờ tiếp nhận tại khoa

PHẦN IV. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

Thời gian	Việc	Phụ trách	Kết quả
Tuần 1–2 tháng 10/2026	Trình ký QĐ-C6.3, SOP-C6.3-01/02, SOP-C6.1-01/02, SOP-D2.4/D2.4A	Trưởng PĐD	Văn bản có hiệu lực
Tháng 10/2026	Tập huấn 19 ĐDT và điều dưỡng; đo số liệu nền KPI C6.3	PĐD	Danh sách tập huấn, số liệu nền
Tháng 10/2026	Phân tích 38 sự cố năm 2026	PĐD, Phòng QLCL	38 sự cố có nhóm sự cố, nguyên nhân
Tháng 11–12/2026	Giám sát theo kế hoạch, nhập KPI tháng vào NT Nursing	ĐDT khoa, PĐD	2 tháng số liệu
Tháng 12/2026	Khảo sát hài lòng quý IV; họp HĐĐD cuối năm; tự đánh giá tiêu chí	PĐD, HĐĐD	Biên bản, bảng tự đánh giá
Quý I/2027	Duy trì giám sát, báo cáo đề án cải tiến C6.3	PĐD	Đủ 6 tháng số liệu cho mức 5

Ghi chú: *Mức 5 của C6.3 cần chứng minh xu hướng cải thiện qua thời gian; nếu bắt đầu giám sát từ 10/2026, đến kỳ đánh giá cuối năm 2026 mới có khoảng 2–3 tháng số liệu. Khả năng đạt mức 5 vững chắc là từ kỳ đánh giá năm 2027.*

PHẦN V. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 (Văn bản hợp nhất 26/VBHN-VPQH).
- Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện.
- Thông tư 32/2023/TT-BYT quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Phụ lục XII được sửa đổi bởi Thông tư 25/2026/TT-BYT.
- Thông tư 43/2018/TT-BYT hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Thông tư 16/2018/TT-BYT quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Thông tư 18/2020/TT-BYT quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện.
- Quyết định 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (phiên bản 2.0).
- Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư (thể thức văn bản ban hành).

Ghi chú: *Ngày tra cứu hiệu lực theo danh mục căn cứ pháp lý của Phòng: 24/9/2026. Đề nghị kiểm tra lại hiệu lực trước khi ký ban hành.*

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc (để duyệt);
- Hội đồng Điều dưỡng;
- Phòng QLCL;
- Điều dưỡng trưởng 19 khoa;
- Lưu: PĐD.

TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG